Dezestra



Essitalopram

Tabletka 10 mg / 20 mg, №28 / №56

Antidepressant, SSRI (N06AB10)

QISQACHA · **10 mg kuniga 1 marta, maks. 20 mg; keksalarga 5–10 mg. MAO ingibitorlari va QT uzaytiruvchilar bilan emas.**

Ko'rsatmalar

- Katta depressiv epizodlar
- Agorafobiyali/agorafobiyasiz vahima buzilishi
- Ijtimoiy xavotirli buzilish (ijtimoiy fobiya)
- Tarqalgan (generalizatsiyalangan) xavotirli buzilish
- Obsessiv-kompulsiv buzilish

Dozalash

- Kuniga 1 marta, ovqatdan qat'i nazar; maks. 20 mg/sut
- Depressiya, TXB, OKB, ijtimoiy xavotir: 10 mg → kerak bo'lsa 20 mg
- Vahima buzilishi: 1-hafta 5 mg, keyin 10 mg (maks. 20 mg)
- Keksalar >65, jigar buzilishi, CYP2C19 sust metabolizatorlar: 5 mg → maks. 10 mg
- Depressiyada simptom ketgach kamida 6 oy; to'xtatish 1–2 hafta davomida asta

Mumkin emas

MAO ingibitorlari bilan (to'xtatgandan 14 kun keyin), moklobemid, LINEZOLID; QT uzayishi yoki tug'ma uzun QT; QT uzaytiruvchi dorilar bilan; o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, bosh og'riq, uyqusizlik/uyquchanlik, terlash, libido kamayishi, eyakulyatsiya buzilishi; kam — serotonin sindromi, giponatriemiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Javob 2–4 haftada; vahimada maksimal samara ~3 oyda
- Tramadol, triptanlar bilan serotonin sindromi; antikoagulyant/NYaQP bilan qon ketish xavfi
- 18 yoshgacha qo'llanmaydi; emizish tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Vahima buzilishida Dezestra qanday boshlanadi?
Birinchi hafta 5 mg, keyin 10 mg/sut; kerak bo'lsa 20 mg gacha.

Dezestra qaysi antibiotik bilan mumkin emas?
Linezolid (Laen) — qaytariluvchan noselektiv MAO ingibitori, serotonin sindromi xavfi.